THORAX · TH-02

# Dépistage pulmonaire · Lung-RADS v2022

**ACR Lung-RADS v2022 · ACR AC Indolent 2026**
scanner faible dose de dépistage

## CATÉGORIES LUNG-RADS V2022 (SCANNER FAIBLE DOSE DE DÉPISTAGE)

| CATÉGORIE | NODULE SOLIDE | PARTIELLEMENT SOLIDE | VERRE DÉPOLI | CONDUITE |
|---|---|---|---|---|
| 0 incomplet | Examen antérieur à récupérer, poumon non évaluable, ou aspect infectieux/inflammatoire (consolidation, > 6 nouveaux nodules, gros nodule apparu rapidement) | | | Comparaison ou scanner à 1–3 mois |
| 1 négatif | Pas de nodule, ou nodule à calcification bénigne ou graisse | | | Scanner à **12 mois** |
| 2 bénin | < 6 mm ; nouveau < 4 mm ; juxtapleural typique < 10 mm | < 6 mm au total | < 30 mm, ou ≥ 30 mm stable ou à croissance lente | |
| 3 probablement bénin | 6–< 8 mm initial ; nouveau 4–< 6 mm | ≥ 6 mm au total, composante solide < 6 mm ; nouveau < 6 mm au total | ≥ 30 mm initial ou nouveau | Scanner à **6 mois** |
| 4A suspect | 8–< 15 mm initial ; croissance < 8 mm ; nouveau 6–< 8 mm | Composante solide 6–< 8 mm ; nouvelle ou croissante composante solide < 4 mm | — | Scanner à **3 mois** ; TEP-TDM si solide ≥ 8 mm |
| 4B très suspect | ≥ 15 mm initial ; nouveau ou croissant ≥ 8 mm | Composante solide ≥ 8 mm ; nouvelle ou croissante composante solide ≥ 4 mm | — | Scanner diagnostique ± injection, TEP-TDM, prélèvement ; avis RCP |
| 4X | Catégorie 3 ou 4 avec signe supplémentaire suspect (spiculations, adénopathie, aspect évolutif…) | | | |

**Croissance :** augmentation du diamètre moyen **> 1,5 mm** en 12 mois. Diamètre moyen arrondi à 0,1 mm (et non plus au mm). Nodule à croissance lente sur plusieurs examens sans franchir le seuil : 4B possible (solide ou partiellement solide), 2 pour un verre dépoli.

## NOUVEAUTÉS V2022

### Kystes atypiques

- 4A paroi épaisse (≥ 2 mm) ou multiloculé
- 4B croissance de la paroi ou des cloisons, plus de loges ou de densité
- 3 kyste à paroi épaisse stable dont la composante kystique croît
- Kyste uniloculaire à paroi fine : hors Lung-RADS

### Nodules des voies aériennes

- 2 sous-segmentaire, ou aspect bénin (air, absence de tissu)
- 4A nodule endotrachéal ou endobronchique solide, segmentaire ou plus proximal
- 4B persistant au scanner à 3 mois → bronchoscopie

### Prise en charge « par paliers »

- 4A stable à 3 mois → 3, scanner à 6 mois
- 3 stable à 6 mois → 2, scanner à 12 mois
- Délais comptés depuis la date de l'examen en cours
- 4B prouvé bénin → reclasser selon le nodule le plus suspect

## MODIFICATEUR S ET CAS PARTICULIERS

**S**
découverte significative non pulmonaire (coronaires, emphysème, masse…) ; inutile si déjà connue ou traitée

**Cavité**
si la partie tissulaire dépasse la cavité : classer comme nodule tissulaire

**Juxtapleural**
solide, ≤ 10 mm, lisse, triangulaire, lentiforme ou ovale (périscissural, costal, médiastinal, diaphragmatique) → 2

**Plusieurs nodules**
la catégorie finale suit le nodule le plus suspect

## CANCER PULMONAIRE INDOLENT · NOUVEAU CRITÈRE ACR 2026

**ACR AC « Indolent Lung Cancer » (JACR, oct. 2026)** — Les nodules subsolides persistants ou à croissance lente et les **kystes atypiques** représentent souvent des formes indolentes de cancer du poumon. Leur prise en charge se décide en **staff multidisciplinaire** (risque, histoire naturelle, options thérapeutiques, préférences du patient).

### Surveillance différée

- Si le staff préfère la surveillance à l'intervention : **scanner thoracique sans injection**, aux intervalles Lung-RADS/Fleischner
- Objectif unique : **détecter les changements qui modifieraient la conduite** — croissance de la composante solide, nouveaux nodules, nouveaux signes
- La radiographie ne surveille pas les lésions subsolides

### Si le traitement est décidé

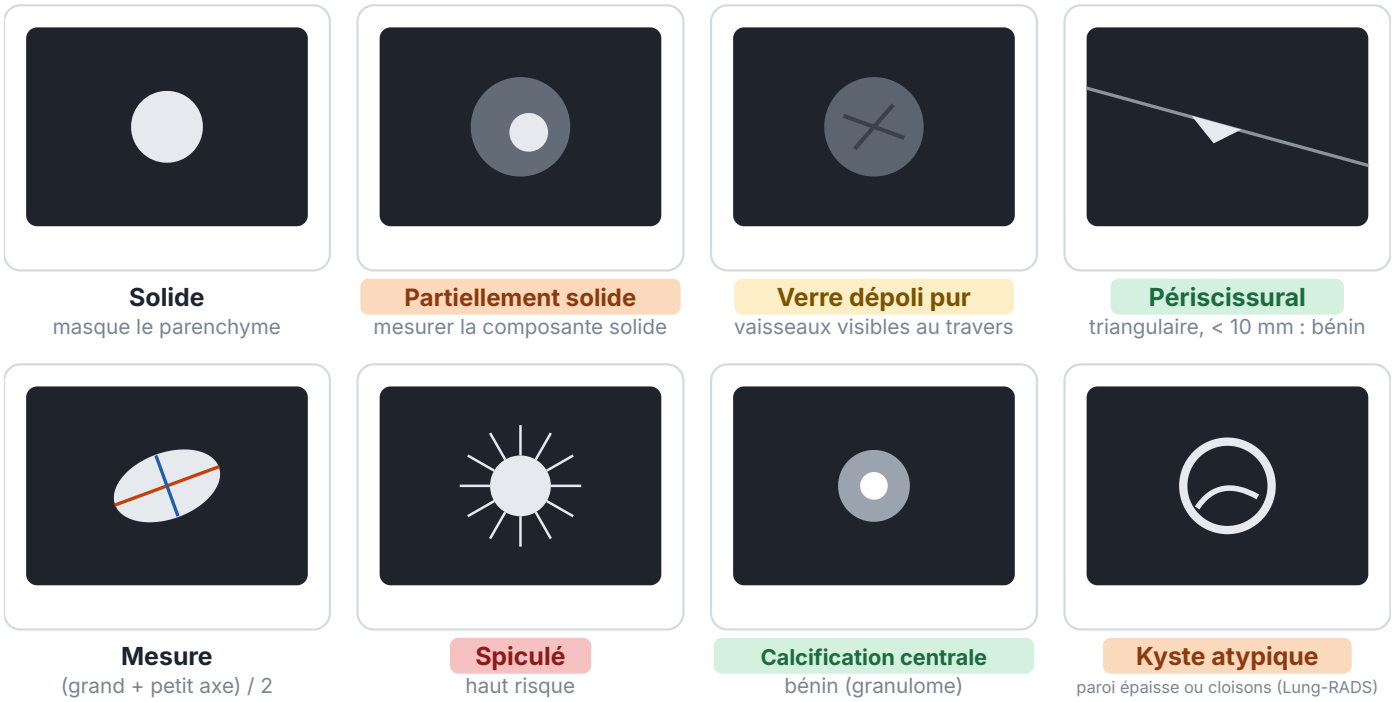
- Le **bilan d'imagerie diagnostique** (scanner ± injection, TEP-TDM) et la **biopsie** sont alors indiqués
- Ils **ne font pas partie de la surveillance** : les séparer clairement dans le compte rendu et le programme de suivi
- Choix de la modalité selon ce qui **modifiera la décision de traiter**

# Dépistage pulmonaire · Lung-RADS v2022 (suite)



## ATLAS VISUEL

### Types de nodules et mesure



**Solide**
masque le parenchyme

**Partiellement solide**
mesurer la composante solide

**Verre dépoli pur**
vaisseaux visibles au travers

**Périscissural**
triangulaire, < 10 mm : bénin

**Mesure**
(grand + petit axe) / 2

**Spiculé**
haut risque

**Calcification centrale**
bénin (granulome)

**Kyste atypique**
paroi épaisse ou cloisons (Lung-RADS)

Schémas simplifiés, non à l'échelle · fenêtre parenchymateuse

Mêmes types de nodules que pour Fleischner ; en dépistage, la catégorie dépend de la taille et du type (voir le tableau).

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Lung-RADS**
Radiopaedia · catégories v2022
radiopaedia.org/articles/lung-rads

**Dépistage du cancer du poumon**
Radiopaedia · essais et population
radiopaedia.org/articles/lung-cancer-screening?l

**Nodule en verre dépoli**
Radiopaedia · aspects
radiopaedia.org/articles/ground-glass-density-no

**Lung-RADS v2022 (ACR, PDF)**
Tableau officiel
cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/Lung-RADS/Lung

**Sources :** ACR Lung-RADS v2022 Summary – cs.acr.org/-/media/ACR/Files/RADS/Lung-RADS/Lung-RADS-2022-S... · Lung-RADS v2022 (Dartmouth) – geiselmed.dartmouth.edu/radiology/wp-content/uploads/sites/4... · ACR AC Indolent Lung Cancer 2026 (PubMed) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42573542/ · ACR AC Indolent Lung Cancer (JACR, oct. 2026) – doi.org/10.1016/j.jacr.2026.07.003